

05 - 05- Maladies inflammatoires de l'intestin Partie I - Pr. Krati

Bonjour, on va voir dans ce cours la première partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc on va voir d'abord leurs classifications, leur épidémiologie, leur étiopathogénie, leur physiopathologie, les différents aspects anatomopathologiques. Ensuite, nous traiterons la maladie de Crohn.

On va voir son expression clinique et paraclinique. On va voir ses aspects ou ses formes cliniques en fonction de la topographie et des formes évolutives. On va voir comment mener l'enquête pour poser le diagnostic de la maladie de Crohn, comment faire la distinction avec les autres maladies qui ne peuvent pas donner les mêmes symptômes que la maladie de Crohn.

Et on va voir l'évolution et les complications de la maladie de Crohn. Et dans le cours prochain, on verra la rectocolite hémorragique avec les principes thérapeutiques et on va insister sur les diagnostics différenciés. Donc déjà, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin se répartissent dans la rectocolite hémorragique, ce qu'on appelle aussi la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn.

Et si on n'arrive pas à classer, si le tableau n'est pas clair entre la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, c'est ce qu'on appelle donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin inclassées. C'est quoi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? Donc, c'est des maladies qui touchent essentiellement le sujet jeune, qui évoluent par poussée, entrecoupée, de phase, de rémission et leur étiologie multifactorielle, même si on ne connaît pas la cause exacte. Ces maladies inflammatoires intéressent le tube digestif et ils peuvent aussi s'accompagner de manifestations extra-digestives dont les plus fréquentes sont représentées par les manifestations dermatologiques, ostéo-articulaires, ophtalmologiques épaisses.

Il faut savoir que la maladie de Crohn touche tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus et de façon segmentaire. Pourquoi de façon segmentaire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas une atteinte continue. On peut avoir une atteinte au niveau de l'ilion tout seul, au niveau de l'ilion au genome, au niveau de l'estomac, le colon.

Donc, c'est une répartition qui est hétérogène et qui se sépare par des intervalles de mycose saine et parfois même au niveau du même segment, on va voir des atteintes qui touchent une partie de façon non-continue. Donc, c'est des atteintes qui sont volontiers plurifocales et sur le plan histologique, c'est des atteintes transmursales qui intéressent toute la paroi. Donc, c'est une atteinte profonde touchant toutes les tuiles.

Par contre, la rectocolite hémorragique, elle, elle touche uniquement le colon et ça démarre en général à partir du rectum de façon continue vers le reste du colon. Et au niveau histologique, c'est une atteinte qui est superficielle, qui généralement respecte la musculature et la serrure. Les maladies inflammatoires de l'intestin, ce qu'on appelle aussi les NICI ou les MICI, c'est des

maladies dont le diagnostic repose sur un vaisseau d'arguments qui est clinique, biologique, radiologique, endoscopique et histologique.

C'est des maladies ubiquitaires parce qu'ils touchent tout le globe, mais avec des prévalences donc variables. Et vous voyez sur cette diapo que les zones les plus touchées où la maladie se voit de façon plus, avec une prévalence plus élevée, ça reste l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est une maladie du sujet jeune, que ce soit le crâne et la rectocolite hémorragique.

Et donc, pour la maladie de Crans, on peut souvent, on peut l'avoir aussi chez l'enfant, chez l'enfant très jeune. Et là, c'est généralement au-delà, à partir de 10 ans. Pour la rectocolite hémorragique, généralement, ça démarre entre 15 et 30 ans.

Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième pic entre 60 ans et 80. Elle touche aussi bien l'homme que la femme et on note une discrète prédominance de la femme en ce qui concerne la rectocolite hémorragique. Il est rapporté que les pays industrialisés sont plus touchés que les moins industrialisés.

Il est rapporté aussi qu'elle est plus fréquente dans le milieu urbain. Donc, c'est des remarques. Et ce qu'il faut savoir aussi, pour la prévalence, par exemple, si on prend l'Europe, la maladie de Crans a une incidence de 3,7 à 7 nouveaux cas par 100 000 habitants par an, avec une prévalence de 150 000 pour 100 000 habitants.

Concernant la RCH, l'incidence est de 2 à 10 nouveaux cas par 100 000 habitants par an. Et pour la prévalence, c'est de 50 par 100 000 habitants. Les statistiques ont montré que l'incidence de la RCH est stable, alors que celle de la maladie de Crans est en augmentation.

Pour la physiologie ou la physiopathologie, il faut savoir que, comme ça a été dit dans l'introduction, qu'il n'y a pas de facteur étiologique évident. Mais les études épidémiologiques ont remarqué que la maladie de Crans ou la RCH, ces maladies, ont un caractère familial. Donc, on les voit dans certaines familles de façon plus fréquente par rapport à d'autres, ce qui suspecte une prédisposition génétique.

On a aussi parlé des facteurs environnementaux. Par exemple, il y a plusieurs facteurs environnementaux qui ont été suspectés, mais le tabac semble être le facteur le plus incriminé dans la maladie de Crans. Donc, c'est un facteur de risque qui est identifié avec un risque relatif de 2, bien que le mécanisme reste inconnu.

Et le tabac augmente la gravité de la maladie de Crans et la non-réponse au traitement. Il favorise la récurrence chez des patients. Donc, la récurrence de la maladie chez des patients opérée.

Et ce risque, il semble être dose dépendante. Et c'est pour ça que dans la maladie de Crans, on insiste sur le sevrage du tabac. Contrairement à la RCH, parce que dans la RCH, le tabac semble avoir un effet bénéfique.

Parce qu'il a été remarqué que la RCH est moins fréquente chez les flumeurs et il semble être moins sévère chez les flumeurs, et souvent on trouve que la première poussée coïncide avec un sevrage tabagiste. Cependant, il est déconseillé aux patients porteurs de RCH de leur demander de démarrer de flume, vu les effets indésirables et les conséquences du tabac sur la santé. Par contre, pour tous les autres facteurs environnementaux, que ce soit le facteur alimentaire, infectieux, antibiotiques, aucun facteur n'a été retenu.

Sur ce tableau-là, il résume les facteurs environnementaux, tous les facteurs environnementaux qui ont été soit suspectés à effet favorable, soit suspectés à effet défavorable pour la maladie de Crohn de la RCH. Comme vous le voyez, les seuls qui ont un effet qui semble avoir un impact sur la soie négative de la maladie de Crohn de la RCH, ça reste le tabac. Le reste, ça reste des suppositions sans aucune preuve.

Sur le plan physiopathologique, c'est bien que ces facteurs, donc il n'y a pas d'éthiologie évidente, il n'y a pas de facteur évident. Ce qu'on sait maintenant, c'est que chez des patients qui sont très disposés, exposés à un certain nombre de facteurs environnementaux, entre autres le mode de vie ou d'autres agents, chez ces patients, il y aura une rupture de la tolérance à la flore digestive, ce qui va aboutir à une activation anormale du système immunitaire intestinal avec libération de certains cytokines ou interleukines ou intégrines qui sont pro-inflammatoires et qui vont aboutir à une inflammation chronique de la muqueuse intestinale qui serait à l'origine des lésions des muqueuses et des syncelines. Cette compréhension de la physiopathogénie a permis de proposer des traitements.

C'est pour ça que dans cette maladie, on peut proposer des anti-inflammatoires comme les corticoïdes ou les salicylés et on peut même proposer des immunosuppresseurs qui vont agir un petit peu moins et éviter l'inflammation. Si on prend les corticoïdes et les salicylés, ils agissent sur les symptômes. C'est un traitement qui symptomatise.

Il n'arrête pas l'inflammation mais il évite les lésions et il diminue les syncelines. Les immunosuppresseurs comme l'azathioprine par exemple ou la cyclosporine, ils agissent un petit peu avant l'inflammation. Plus récemment, ces dernières années, grâce au développement de la biothérapie représentée par les entités NF et autres, on peut agir un petit peu plus loin sur le système immunitaire en bloquant soit les cytokines, les interleuquines ou les anti- ou les intélus.

C'est une vraie avancée dans la prise en charge de traitements de ces maladies. Certes, on n'a pas encore un traitement curatif mais on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces et qui peuvent modifier l'histoire de la maladie. Sur le plan anatomopathologique, concernant la maladie de Crohn, déjà pour la topographie, comme je l'ai dit au cours de l'introduction, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif et de façon hétérogène.

Sachez que le grêle est touché dans 70% avec une grande atteinte ou une fréquence atteinte de la région ileale. Pour le colon, il est touché dans 70%. Il y a aussi l'atteinte de la région

anopérinéale, un tiers des cas.

Mais il faut savoir qu'il peut toucher aussi l'estomac, il peut toucher aussi l'œsophage moins fréquemment que le grêle, le colon et la région anopérinéale. Il faut aussi savoir sur le plan topographique qu'on peut avoir deux ou trois localisations associées. On peut avoir de multiples localisations.

Sur le plan macroscopique, c'est-à-dire quand on ouvre l'intestin et qu'on ouvre une endoscopie, on va voir que l'atteinte est segmentaire et discontinue, c'est-à-dire qu'on a des zones malades et des zones saines et que les ulcérations qui sont observées sont très profondes ou superficielles. Les lésions superficielles représentent des lésions aphtoïdes, mais les lésions profondes peuvent être fissuraires, donc elles peuvent toucher toute la paroi et même être à l'origine de fissures. Ça se traduit sur le plan microscopique par, comme on l'a dit au cours de l'introduction, par une atteinte transmurale.

Il y a pour conséquence les fissures, les fistules, et ces fistules et ces fissures peuvent être à l'origine d'abcédations. Lorsqu'ils sécrétisent, ils peuvent être à l'origine de sténose de la lumière intestinale et puisque l'atteinte est transmurale et profonde, l'inflammation peut être à l'origine d'une inflammation de la graisse mésentérique qui va être hypertrophiée et inflammée. C'est un signe qui est très en faveur de la maladie chronique.

Comme c'est une maladie chronique, on peut avoir des signes d'inflammation de la muqueuse chronique, comme l'atrophie de la muqueuse, la désorganisation glandulaire et l'infiltrat infoplasmodaire. La lésion élémentaire caractéristique, c'est le granulome hypothéologique ontocellulaire sans l'écrasement caselle. C'est une lésion élémentaire très importante, sauf que cette lésion ne s'observe que dans un tiers des grains.

C'est-à-dire que sa découverte est un élément qui est en faveur de la maladie chronique, mais son absence ne permet pas d'écarter le diagnostic de maladies de chronique. Il faut savoir aussi que le granulome hypothéologique ontocellulaire peut se voir dans d'autres maladies que la maladie de chronique, comme la tuberculose par exemple, et comme la sarcoïdose. Concernant la rectocolite hémorragique, c'est une maladie qui touche uniquement le côlon.

Ce qui est constamment observé, c'est que le rectum est toujours atteint, ça démarre en général au niveau du rectum et ça remonte de plus en plus sur le côlon de façon ascendante. Et il respecte le grain, ça c'est très important. C'est une atteinte qui continue, on ne trouve jamais d'intervalle de myocènes entre les lésions.

L'extension se fait de façon rétrograde du rectum de plus en plus étendue vers le côlon. Dans la maladie de chronique, dans la rectocolite hémorragique, l'atteinte rectale ou rectosigmoïdienne reste la plus fréquente, elle est observée dans la moitié des cas. Et dans 20% des cas, on va trouver une atteinte de tout le côlon, c'est ce qu'on appelle la pancolite.

Sur le plan macroscopique, l'atteinte superficielle va se manifester soit par un aspect granité, soit par une mycose qui est fragile, qui s'aime facilement au contact de l'endoscope, qui est hémorragique et qui peut être associée à des ulcérations superficielles en cas géographique de la mycose. Lorsqu'elles sont profondes, c'est un signe de gravité. Les aspects évocateurs sur le plan microscopique, c'est la présence des lésions qui prédominent au niveau de la mycose et sur la partie superficielle de la somiqueuse.

Donc, en général, ils respectent la musculature. Ils sont caractérisés par une perte de substance, avec un infiltrat lymphoplasmositaire du cordon, avec des abcès cryptiques, avec une perte de la mycose crescent, une modification de l'architecture des glands. C'est un aspect qui est très caractéristique de la rectocolite hémorragique.

Lorsqu'on veut rechercher cet aspect caractéristique, il faut le rechercher chez des patients en absence qui n'ont pas eu de traitement. Parce que quand ils prennent le traitement, ces aspects caractéristiques peuvent devenir un petit peu hétérogènes. Lorsque la maladie évolue et devient ancienne, on peut avoir des signes en faveur, comme un aspect d'une inflammation chronique atténuée et inhomogène.

Et dans cette situation-là, il y a un risque de dysplasie et de dégénérescence qui est important. Sur le plan anatomopathologique, il y a certains éléments qui peuvent différencier la maladie de Crohn de la rectocolite hémorragique. Dans la maladie de Crohn, les lésions sont segmentaires, sont focales, avec des intervalles de mycose saine.

Alors que dans la rectocolite hémorragique, les lésions sont diffuses, continues, sans intervalles de mycose saine. Les lésions sont hétérogènes dans la maladie de Crohn, elles sont homogènes dans la rectocolite hémorragique. Généralement, les aspects cryptiques sont possibles dans la maladie de Crohn, mais sont enfoyés, alors qu'ils sont très nombreux dans la rectocolite hémorragique.

Le granulome épithélio-gé-quantocellulaire, on va le trouver dans 30% des maladies de Crohn. Par contre, on ne le trouvera jamais dans la rectocolite hémorragique. La mycose création, elle est conservée dans la maladie de Crohn, elle est réduite dans la rectocolite hémorragique.

Et il faut savoir que les amas lymphoïdes basales au niveau du chorion sont rares dans la maladie de Crohn, mais ils sont fréquents dans la rectocolite hémorragique. Généralement, ces aspects permettent, sur le plan anatomopathologique, de faire le diagnostic différentiel entre les deux maladies. Maintenant, on va voir la maladie de Crohn, ses aspects cliniques, biologiques, morphologiques, endoscopiques, et on va voir comment on va faire le diagnostic.

Donc déjà, la maladie de Crohn, c'est comme la RCH, c'est une maladie qui est voulue en poussée, entrecoupée de phases de rémission qui peuvent être plus ou moins complètes et plus ou moins prolongées. C'est-à-dire, il y a certaines maladies qui vont présenter, entre les

poussées, des phases où elles seront complètement asymptomatiques, avec une durée qui est variable de l'individu, qui peut durer qu'un mois ou des années. Et il y a certains patients qui ne seront jamais en rémission complète.

Il faut savoir aussi, de façon globale, pour la maladie de Crohn, que la symptomatologie est polymorphe. Pourquoi elle est polymorphe? Pourquoi il n'y a pas un seul tableau? Il y a plusieurs tableaux et plusieurs expériences cliniques. Tout simplement parce que la symptomatologie dépend de la topographie.

On sait que les topographies, les atteintes sont variables. Ils peuvent toucher les jambes, toucher le côlon, toucher le rectum, toucher l'estomac, toucher le jugement. En fonction de la topographie, la symptomatologie, bien sûr, sera différente.

Il dépend aussi de l'étendue des lésions. Plus les lésions sont étendues, plus le tableau est plus expressif. Il dépend aussi du phénotype de la maladie.

Concernant les signes qu'on peut voir, dans la maladie de Crohn, on peut avoir des signes généraux, des signes digestifs et des signes extra-digestifs. Maintenant, quels sont les signes généraux? D'abord, l'altération de l'état général. Il faut savoir que dans la maladie de Crohn, l'amégaïssement est souvent marqué.

Pourquoi? Parce qu'il s'associe souvent d'un hypercatabolisme. Et lorsqu'on a une atteinte au niveau de jejunum et de doudunum étendue, il peut être associé à une malabsorption. C'est une maladie qui peut s'accompagner souvent d'asthémie.

Et lorsqu'il se déclare pendant l'enfance, il peut avoir un retentissement sur le développement staturopondéral de l'enfant. Et on peut parfois avoir, si le malade n'est pas pris en charge correctement et de façon précoce, on peut avoir un retard staturopondéral. Parmi les signes généraux, on a la fièvre.

Il faut savoir que toute maladie inflammatoire chronique de l'intestin, que ce soit le Crohn ou le RCH, lorsqu'il s'associe à une fièvre, ça signe la gravité de la maladie et ça constitue une urgence de prise en charge. Généralement, ça masque ou ça cache une poussée sévère de la maladie ou une poussée ou une forme compliquée de la maladie, ou que le malade présente une colite grave ou une forme fistulosante ou abscondée ou une surinfection. Donc la fièvre, c'est un signe d'alarme dans la maladie de Crohn.

Maintenant, concernons les signes digestifs. D'abord, il y a la diarrhée. C'est une diarrhée qui est persistante et chronique.

C'est une diarrhée qui est dure, en général, au-delà de 4 semaines. Cette diarrhée peut être liquidienne, en particulier dans les atteintes où il y a le milieu colicoïde droite. Elle peut être glérosanglante en cas d'atteinte colicoïde gauche ou rectocolite.

Il y a aussi les rectoragies et les hémorragies digestives où l'anémie sidéropénique fait réclame. Ça se voit lorsqu'on a soit une hémorragie digestive massive, situation qui est rare. Les rectoragies vont se voir essentiellement en cas d'atteinte colicoïde gauche ou rectale.

Et les anémies, généralement, se voient soit lorsqu'on a une atteinte juginale étendue, parce qu'il y a une gêne du fer, une malabsorption, soit lorsqu'on a une atteinte iliale étendue. Dans ce cas, ça va être plutôt une anémie mégaloblastique liée à un déficit d'absorption de la vitamine B12. Soit dans les situations où il y a des ulcérations, des multiples ulcérations qui saignent de façon continue mais minime.

Ils seront responsables d'un saignement digestif occulte. Et dans ce cas, on aura une anémie ferrocite. Ensuite, on a les douleurs abdominales.

Là aussi, les douleurs abdominales sont variables en fonction de la topographie des lésions. Ils peuvent être chroniques et d'installation progressive. On peut avoir carrément un syndrome de clinique.

C'est quoi un syndrome de clinique ? C'est une crise douloureuse abdominale qui survient en postprandiale avec une intensité qui croît de façon continue, associée parfois à des ballonnements abdominaux et qui va disparaître de façon brusque avec un bourgogne et à la suite d'une débacle de gaz ou de sel. Lorsqu'on a ce syndrome de clinique, il faut toujours suspecter un rétrécissement intestinal, que ce soit grélique ou colique. Le syndrome de clinique doit toujours faire craindre la survenue d'une sténose.

Il n'y a pas une sténose totale, il y a un rétrécissement. Quand il y a la sténose, on aura le syndrome occlusif ou subocclusif. Lorsqu'on a le rétrécissement, il y a quand même un passage, sauf que ce passage se fait de façon difficile.

Donc on a ce qu'on appelle le syndrome de clinique. Parfois, il peut simuler une appendicite parce que la localisation la plus fréquente de la rectocolite de la maladie de Crohn, c'est la région iliale et parfois ça peut donner une douleur de la fossiliaque droite. Donc ça c'est important, toujours sur le sujet jeune, en cas de douleur au niveau de la fossiliaque droite, c'est vrai, il faut penser à l'appendicite, mais il faut penser aussi à la maladie de Crohn.

Les complications qui peuvent révéler la sténose, un abcès abdominal, on va avoir un empyème avec un syndrome infectieux, qui peut aussi se révéler par infection. On a aussi les épigastries, mais on les voit dans les localisations autres. Pour les manifestations anopérénales, il faut distinguer, ça se voit dans un tiers des cas, on a des lésions anopérénales primaires, c'est-à-dire initiales, élémentaires, qui sont représentées par la perte de substance, soit un type de fissure anale ou d'ulcération anale.

On a les lésions anopérénales secondaires, qui traduisent une évolutivité dans la maladie, c'est les fistules anales, les abcès anus et les sténoses. Concernant les manifestations extra-

digestives, ils sont nombreux, on va les voir surtout dans la maladie, je vais les détailler avec la rectocolite hémorragique, mais sachez que les plus fréquentes sont représentées par les manifestations ophtalmologiques, ostéoarticulaires, cutanées, les autres sont plus rares. Attention au cours des maladies inflammatoires de façon globale, là je parle de la maladie de Crohn, mais aussi de la rectocolite hémorragique, faire attention aux manifestations vasculaires et du risque thromboembolique, c'est pour ça que dans les formes sévères, on propose toujours un traitement préventif par les anticoagulants.

Là c'est quelques images des manifestations cutanées, vous avez les rythèmes noeux, qui sont des modules blouâtres, qu'on voit souvent au niveau des membres, au niveau de la jambe ou au niveau de l'avant-bras, ça se voit aussi bien avec la maladie de Crohn qu'avec la RCH, mais avec une fréquence plus importante avec la maladie de Crohn. Là ce qu'on voit c'est des actes bucaux, et là ce qu'on voit c'est le pyoderma gangrénosum, c'est une ulcération profonde sans tendance à la cicatrisation, ça se voit aussi bien dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Maintenant concernant l'expression paraclinique.

Sur le plan biologique, on peut avoir un syndrome inflammatoire documenté par une protéine C réactive élevée, par une hyperleucocytose à PNN ou par thrombocytose. Ce syndrome inflammatoire est fréquent, mais il peut être absent. On peut trouver aussi une anémie, qui peut être une anémie hypochrome-microcytaire en rapport avec une inflammation importante, ou en rapport avec un déficit en fer, ou parfois cette anémie peut être macrocytaire en rapport avec un déficit en vitamine B12.

Le bilan hépatique peut être perturbé, mais c'est un signe, donc c'est une manifestation extra-digestive. Sur le plan immunologique, on peut avoir des anticorps qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas sensibles, mais qui peuvent orienter vers la maladie de Crohn. Ils sont représentés par les ASCA, c'est les anticorps anti-saccharomyces cervides, qui seront souvent positifs dans la maladie de Crohn, mais pas toujours, c'est-à-dire lorsqu'ils sont négatifs, ils n'écartent pas le diagnostic.

Et on a les pancas, c'est les anticorps anti-cytoplasmes des polynucléaires neutrophiles de localisation périnucléaire, qui sont généralement négatifs dans la maladie de Crohn. Il faut toujours faire un bilan infectieux lorsqu'on est devant un contexte de fièvre ou d'infection, parce que la maladie de Crohn peut se compliquer d'accès péri-intestinal. Sur le plan nutritionnel, comme je l'ai dit, en fonction de l'atteinte, on peut avoir un déficit, donc une malabsorption de la vitamine B9, c'est-à-dire du folate, lorsqu'on a une atteinte au niveau duodéno-jejunal.

On peut aussi avoir une malabsorption de la vitamine B12 en cas d'atteinte iléale étendue. On peut avoir aussi une atteinte, un déficit, une malabsorption du calcium. Concernant l'albumine, on peut avoir une hypoalbuminémie.

C'est un signe de gravité. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que l'hypoalbuminémie, le

plus souvent dans la maladie de Crohn, est liée à l'entéropathie exudative, qui est secondaire à cette inflammation de l'intestin, de la muqueuse. Mais il peut aussi être en rapport avec une malabsorption.

Sur le plan endoscopique, ce qu'on demande en général, c'est une exploration du colon et de l'ilion. C'est ce qu'on appelle l'inoscopie. Pourquoi ? Parce que la lésion la plus fréquente siège au niveau de l'ilion et de ses points.

Il faut faire aussi des biopsies au niveau de l'ilion et aussi au niveau du colon. Cette endoscopie permet de faire le diagnostic différentiel. Parce qu'il va éliminer un cancer.

Il va nous montrer les lésions, les caractériser. Et ça permet de préciser le diagnostic positif et d'éliminer les autres diagnostics. Deuxièmement, il permet d'évaluer l'étendue des lésions.

Est-ce que ces lésions sont limitées ou étendues ? Il recherche aussi des signes de gravité endoscopiques. Par exemple, une ulcération profonde et creusante est un signe de gravité. Il permet de dépister une dysplasie ou un cancer colorectal ou ilial.

Maintenant, quels sont les aspects endoscopiques qui nous font évoquer la maladie de Crohn ? C'est la lésion, je le répète parce que c'est très important, c'est la lésion segmentaire, asymétrique, multipocale des lésions. C'est la présence d'ulcérations aphthoïdes ou des ulcérations linéaires et serpiginieuses et creusantes. C'est un élément en faveur du Crohn.

C'est la présence d'espines inflammatoires ou des fistules. Il y a aussi les pseudopolypes inflammatoires qui témoignent de la chronicité de la maladie. Ce qui est important dans la maladie de Crohn, généralement le rectum n'est pas touché de façon constante, mais lorsqu'il est atteint, ça ne nous permet pas d'écarter le diagnostic de la maladie de Crohn.

Ce qui est aussi important, c'est qu'il faut toujours explorer la dernière colique parce qu'il est souvent atteint. C'est-à-dire, s'il n'est pas atteint, s'il est sain, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maladie de Crohn. Généralement, le plus souvent, il est atteint.

C'est un élément qui est en faveur de la maladie de Crohn. La fibroscopie digestive haute sera demandée devant des symptômes qui attirent l'attention vers la partie haute du tube digestif. Le deuxième examen endoscopique, c'est l'enteroscopie double-ballonnée.

C'est un examen qui reste invasif parce qu'on va introduire un endoscope soit par voie basse, soit par voie haute, ou les deux en même temps, qui va nous permettre d'étudier le graine. Cet examen est contre-indiqué en cas dans les formes sténosantes, donc on ne peut pas le faire. Il a un intérêt surtout pour explorer le graine.

C'est un examen qu'il faut faire en général lorsqu'on a orienté, lorsqu'on a une suspicion. On ne va pas le demander de façon systématique, on va le demander lorsqu'on a une suspicion d'une atteinte graine, soit lorsqu'on a une symptomatologie qui attire l'attention vers le graine, soit

quand on a fait un entero-scanner ou une entero-IRM qui a montré des lésions au niveau du grêle, ou lorsqu'on a fait une vidéocapsule qui a montré une endoscopie qui a permis de voir une atteinte au niveau du grêle. Il a son intérêt parce qu'il va permettre de faire début aussi des lésions et de rechercher les lésions histologiques évoquables.

Sur cette diapo, je vais parler. Tout à l'heure, on parlait des caractéristiques et de ce qu'on peut voir. Là, je vous ai choisi quelques images, mais j'insiste surtout pour dire que selon l'aspect des lésions, on peut distinguer les lésions évolutives et les lésions cicatricielles.

Les lésions évolutives sont représentées par les ulcérations superficielles arctoïdes, par les ulcérations en cartes géographiques, par les ulcérations creusantes et profondes, par un aspect pavimentaire de la muqueuse, par des œdèmes de la muqueuse, l'érythème de la muqueuse, les sténoses ulcérées, les orifices fistuleux ulcérés, alors que les lésions cicatricielles, pourquoi il faut distinguer les lésions évolutives des lésions cicatricielles ? Parce que si on trouve des lésions évolutives, ça témoigne que la maladie est encore active, que la maladie va encore se compliquer, que c'est une maladie qui nécessite un traitement en urgence. Par contre, les lésions cicatricielles, elles ont double intérêt. Si on trouve des lésions cicatricielles sans lésions évolutives, ça veut dire que la maladie n'est plus active, elle a laissé des lésions cicatricielles, donc elle est en rémission.

Par contre, si on trouve des lésions cicatricielles associées à des lésions évolutives, ça veut dire que la maladie est ancienne et évolue depuis longtemps parce qu'on trouve la coexistence des deux lésions. Ça témoigne aussi de la chronicité de la maladie, de la gravité de la maladie. Quelles sont ces lésions cicatricielles ? Elles sont représentées par les pseudopolypes, par des cicatrices d'ulcération qui peuvent être de taille variable, par des sténoses cicatricielles, c'est des sténoses fibreuses qui ne sont pas inflammatoires, qui ne sont pas ulcérées.

Donc, ces lésions cicatricielles sont aussi importantes à préciser. Et la coexistence des lésions, je le répète, la coexistence des lésions évolutives avec les lésions cicatricielles, ça témoigne de l'évolutivité de la maladie qui nécessite le traitement et ça témoigne aussi que c'est une maladie ancienne qui évolue depuis longtemps. Maintenant, pour l'exploration endoscopique par la vidéocapsule, c'est une exploration qui n'est pas invasive du grêle, qu'on va faire chez des patients qui ont soit des signes évocateurs du grêle, soit un aspect aussi au niveau de l'entéroscopie, mais il faut savoir qu'il est absolument contre-indiqué lorsqu'on suspecte une sténose.

C'est-à-dire que chez un patient qui a un syndrome de Crohn, c'est un patient qui a eu un syndrome occlusif ou qui fait des syndromes sub-occlusifs, donc il ne faut pas faire cet examen parce que ça expose à la rétention de la capsule. Maintenant, on passe à l'imagerie. Déjà, on a l'abdomen sans préparation, ce qui est marqué là par AFP.

Son intérêt est surtout dans les complications, pas pour le diagnostic de la maladie de Crohn

parce qu'on le demande lorsqu'on suspect une colectasie, une dilatation du côlon, ou lorsqu'on suspect une occlusion. L'échographie et la tomodensitométrie, là aussi, ils ont un intérêt surtout pour rechercher les complications à type d'accès de fustule ou d'occlusion. L'enteroscanère ou l'enteroyerème restent deux examens qui permettent d'étudier et de caractériser la thèse du grêle.

Je vais les détailler par la suite. Le transit du grêle, il avait un intérêt lorsqu'on ne disposait pas des examens comme l'enteroscanère ou l'enteroyerème qui permettent d'étudier mieux la paroi. Maintenant, il a perdu de place.

L'yerempénifien a un intérêt dans les lésions anopérinaires. Là, sur ces diapos, on a déjà un aspect de sténose, en tronçon de pente, au niveau de la partie terminale de l'union. Sur l'image à droite, on a un épaississement de la paroi au niveau de l'échographie.

Sur l'image d'en bas, il montre une sténose illéale de la maladie de Crohn. Vous voyez l'épaississement de la paroi avec le rétrécissement de la lumière. L'enteroscanère, c'est une image qu'on voit là au niveau par l'IRM.

Maintenant, on va parler de l'enteroscanère. L'enteroscanère est différent de scanner parce qu'il va permettre d'étudier la paroi intestinale. Il va préciser l'épaississement parietal.

Il va permettre d'étudier la paroi intestinale. Il va évaluer la graisse péridigestive et voir s'il est inflammatoire. Il permet aussi de mettre en évidence une fustule ou un nabcique.

Ce qui est très important dans cet examen, c'est qu'il permet d'évaluer l'évolutivité de la maladie et de faire le diagnostic différentiel entre un épaississement fibreux, cicatriciel et inflammatoire. C'est très important car ça a un impact au niveau de la prise en charge. Si j'ai une sténose inflammatoire, par exemple, le traitement est médical.

Par contre, si j'ai une sténose fibreuse, le traitement est mécanique, soit la chirurgie, soit une dilatation endoscopique. Donc, si j'ai de l'inflammation, ça veut dire que la maladie est évolutive. Par contre, si j'ai que de la fibreuse, ça veut dire que la maladie est en rémission.

C'est très important à préciser. Malheureusement, c'est un examen qui nécessite que le patient boive beaucoup de liquide. Ça expose à une irradiation non négligeable.

C'est un examen qu'on ne peut pas répéter de façon régulière. On sait que dans la maladie, on a besoin d'explorer le grain et de rechercher ce caractère inflammatoire ou fibreux. En ce qui concerne l'enterolirène, il a les mêmes atouts que l'enteroscanère, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de rechercher l'aspect inflammatoire évolutif.

Elle est moins astreignante que l'enteroscanère. Elle expose moins à l'irradiation. Je dirais même qu'elle n'expose pas à l'irradiation.

Cependant, son seul problème, c'est que c'est un examen qui dépend de l'expertise du médecin. L'enterolirène, il nous faut un radiologue expérimenté dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il peut nous montrer de l'inflammation qui se traduit par un aspect peigné du meso.

Ça veut dire que c'est un meso qui est hypervascularisé. Ça traduit que la muqueuse est inflammatoire. On va parler des formes cliniques.

On a parlé de l'expression de la maladie de Crohn, biologique, morphologique, etc. Mais sur le plan clinique, comment va s'exprimer cette maladie? Dans ces formes cliniques, d'abord, il faut ce qui est très important comme on l'a dit au début, c'est une symptomatologie polymorphe tout simplement parce qu'on peut avoir des atteintes ilial-terminales, des atteintes coliques, on peut avoir des atteintes phénotypiques dans la maladie de Crohn. Il y a la forme fistulosante et pénétrante qui va se manifester par des fistules ou des abcès.

On a les formes fibrosantes et sténosantes. On a les formes inflammatoires. C'est les formes non sténosantes et non fistulosantes.

Si les formes sont plus fréquentes, on a plus de l'inflammation. Il faut aussi savoir qu'on peut l'association de deux ou trois phénomènes en même temps chez le même patient. La symptomatologie peut être très riche.

Un patient peut être d'abord inflammatoire et devenir dans le temps fibrosant, sténosant. Les tableaux sont variables. En fonction des phénomènes, on aura une symptomatologie variable.

Cette variabilité dans le temps des maladies ou d'un malade à un autre a un impact sur le plan diagnostique car il réalise des tableaux différents et sur le plan thérapeutique car ça justifie des traitements spécifiques en fonction des phénomènes. On peut voir les formes cliniques et comment elles vont s'exprimer sur les formes cliniques digestives. On sait que les symptômes digestifs sont représentés par la diarrhée, la douleur, l'anorexie et la maigrité.

Mais en fonction de la topographie, on peut avoir la prédominance de l'un ou de l'autre. Dans les formes iléales, iléo-séquales, iléo-coliques ou iléo-coliques droites, il y a souvent une douleur de la fosse iliaque droite qui peut parfois réaliser un syndrome appendiculaire. Parfois, on peut avoir carrément une masse au niveau de la fosse iliaque droite liée à l'inflammation qui se développe autour de l'intestin ou de l'iléo-séquale.

On peut avoir aussi une diarrhée liquidienne. Dans les formes coliques gauches ou dans les formes qui touchent tout le côlon, on va avoir une douleur abdominale du flanc parce que le cadre oncologique intéresse tout le côlon. On peut avoir aussi des diarrhées glérolanglantes.

Dans les formes jугinales ou étendues du grêle, on peut avoir, parce que l'inflammation peut être à l'origine d'un rétrécissement de la lumière, donc on peut avoir un syndrome subocclusif chronique avec un amaigrissement lié à la malabsorption. On peut aussi avoir le syndrome de

Cunier. Les formes avec manifestation anopérinale peuvent être très importantes.

Le malade ne peut pas avoir aucun symptôme intestinal et il va venir parce qu'il a une fessule ou parfois une fissure très douloureuse ou une perte de substance ou le gène. Ces manifestations anopérinales peuvent être les premiers symptômes de la maladie de Crohn. Dans les formes sténosantes, on n'a pas d'inflammation.

Les formes sténosantes peuvent se manifester par un syndrome de Cunier qui est la douleur que nous avons tout à l'heure décrite. Maintenant, comment poser le diagnostic? En fait, la question est quand est-ce que nous devons évoquer la maladie de Crohn? Il faut l'évoquer devant toute diarrhée prolongée chronique. Il faut l'évoquer devant toute fissure axée au fustule anale.

Il faut l'évoquer devant toute douleur abdominale inexpliquée. Il faut l'évoquer devant toute altération de l'état général. Il faut l'évoquer devant des manifestations extradigestives notamment un érythème noueux, un biodermite gangréneux, une douleur articulaire, une manifestation oculaire, conjonctive, hiérarchique, etc.

Il faut l'évoquer aussi devant une anémie qui peut être sideropénique ou mégaloblastique. Il faut l'évoquer aussi devant un syndrome biologique inflammatoire inexpliqué. Il faut l'évoquer devant un syndrome biologique de malabsorption inexpliqué.

Mais pour poser le diagnostic, il faut essayer de constituer le faisceau d'argument qui est représenté déjà par les données épidémiologiques cliniques, donc l'âge du patient. Il faut penser aux maladies inflammatoires sur le sujet jeune. J'ai un patient qui décrit la symptomatologie avec des poussées antérieures, c'est-à-dire un profil évolutif, chronique, poussée, rémission, poussée, rémission.

Lorsqu'on a autour dans les antécédents familiaux du patient une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique ou une colite inclassée, il faut l'évoquer lorsqu'on a les symptômes digestifs associés à des manifestations extra-digestives ou devant des lésions anopérinées. Il y a aussi l'aspect endoscopique devant l'atteinte multifocale, hétérogène, etc. Lorsqu'on a des lésions histologiques évoquant cette atteinte transmurale, c'est une sération profonde fissuraire, la présence de granulomes et peut-être d'ongéon tocellulaire.

Et bien sûr, il faut éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent donner une colite, une lélite ou une atteinte du grain qui soit d'origine infectieuse, parasitaire, médicamenteuse, ischémique, tumorale. Il faut éliminer une tuberculose en particulier dans la localisation idiosécale parce que c'est la localisation la plus fréquente aussi de la tuberculose. Il faut éliminer une origine tumorale.

Et bien sûr, lorsqu'on a un Crohn-colite, il faut aussi écarter une RCH. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui généralement évolue par poussée entrecoupée de phases de rémission. Cette histoire naturelle de la maladie de Crohn, elle est variable d'un individu à un autre, c'est-à-dire que certains peuvent avoir une atteinte qui est continue sans intervalle de myocènes.

Cet intervalle de mycènes peut être variable, donc il peut être court chez certains ou plus long. Et bien sûr, au cours de l'évolution, on peut passer d'une forme inflammatoire non délabrante vers une forme fibrosténosante ou vers une forme pénétrante ou perforante ou d'une forme fibrosténosante-fibrose vers une forme inflammatoire ou d'une forme perforante ou pénétrante vers les autres. La maladie de Crohn, généralement, s'il est bien pris en charge, il ne retentit pas sur l'espérance de vie du malade.

Et donc, le malade, s'il est pris en charge correctement, peut avoir une vie normale. Là, j'ai mis l'indice du sédaïs, qu'on appelle aussi l'indice du test, qui permet de classer les poussées entre une poussée sévère et une poussée légère et des formes aussi inactives. Il est basé sur le nombre de selles, la douleur abdominale, le bien-être du patient, les manifestations extra-digestives, s'il y a une masse abdominale ou non, sur le poids du malade et les matocytes.

Généralement, la maladie évolue dans la majorité des cas par des poussées entrecoupées de phases de rémission. Il faut savoir que la maladie de Crohn peut rester latente chez un individu, ne s'exprimer pas, comme on peut avoir des formes chroniques avec une altération de la qualité de vie. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de surmortalité par rapport à la population générale.

S'ils sont pris en charge correctement, ce sont des maladies qui peuvent se compliquer. Les complications sont représentées par les sténoses intestinales qui vont aboutir à l'occlusion, par les perforations, par les abcès hépatiques, par les fustules, qui peuvent être entre les différents segments du tube digestif, ou entre le tube digestif et la paroi, ce qui donne la fustule entéro-planine, ou entre le tube digestif et un autre organe de voisinage, par exemple une fustule unio-physicale, une fustule unio-utérine, etc. Il y a aussi parmi les complications la colectomie, ce qu'on appelait autrefois le mégacolon, le mégacolon toxique.

C'est une complication qui est grave, mais heureusement qu'il est rare. On a aussi les hémorragies digestives massives qui peuvent être responsables d'un choc hémorragique, mais là aussi c'est une complication grave. Il y a le risque infectieux.

Il y a les complications de thromboembolie, d'ailleurs il faut les prévenir chaque fois qu'on est devant une forme sévère ou un processus sévère. Ce sont des maladies où il y a un hypercatabolisme et ils peuvent aussi retentir sur l'absorption. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une dénutrition avec des complications osseuses, soit type d'ostéopénie, ou d'ostéoporose.

La maladie de Crohn, comme toutes les maladies inflammatoires du intestin, expose à la dégénération. Pour conclure, je dirais que la maladie de Crohn est une maladie dont la physiopathologie reste multifactorielle et mal comprise. Son diagnostic repose essentiellement sur les données de l'endoscopie et de l'histologie, mais aussi sur le faisceau d'acclimation.

Le pronostic vital lorsqu'il est pris en charge correctement, n'est peut-être pas respecté. Leur prise en charge, on va la voir par la suite, repose sur une prise en charge multidisciplinaire. Il a

bien profité des progrès réalisés dans le traitement par la découverte de la biothérapie.

Attention, dans la maladie de Crohn, il y a le risque de dégénérescence, donc l'intérêt de la surveillance.